Kolagenózy: praktický klinický pohľad nefrológa na diagnostiku, orgánové riziko a rozhodovanie o liečbe

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Ochorenie je jedno, orgánov zasiahnutých viac – a oblička často rozhoduje o prognóze.

Pri kolagenózach sa v praxi opakujú dva problémy: diagnóza sa nedá postaviť na jednom vyšetrení a orgány môžu byť ohrozené skôr, než sa klinický obraz jednoznačne vyhraní do konkrétnej nozologickej jednotky. O úspechu diagnostiky preto rozhoduje najmä to, ako systematicky reumatológ mapuje symptómy, laboratórne nálezy, zobrazenie a funkciu orgánov.

Podujatie Streamed Up (RheumaLive, Kollagenosen 2026) označuje túto oblasť za takú, ktorá prináša výrazné **diagnostické aj terapeutické výzvy** naprieč rôznymi formami ochorení. Nasledujúce zhrnutie je praktické – na každodenné uvažovanie v ambulancii aj na internom oddelení.

1) Diagnostika nie je pomenovanie. Diagnostika je posúdenie rizika pre orgány

Od bežného nešpecifického príznaku sa kolagenóza líši tým, že sa môže prejavovať rôzne a jej obraz sa často mení v čase. Postup sa preto opiera o:

- anamnézu a fyzikálne vyšetrenie zamerané na typické symptómy,
- laboratóriá doplnené o vyšetrenie funkcie postihnutých orgánov,
- zobrazovanie (napríklad ultrazvuk, RTG),
- a podľa potreby aj mikroskopické vyšetrenie tkaniva z biopsie, ak to zmení diagnostiku alebo terapiu.

„Správna diagnóza“ je tu prostriedkom, nie cieľom. Cieľom je včas zachytiť, či už nejde o orgánové poškodenie, a určiť, ako naliehavo treba konať.

2) Najdôležitejšie „orgánové okná“ v každodennej práci

A) Obličky: ako spoznať prebiehajúcu nefritídu

Pri systémovom lupus erythematosus treba v praxi počítať s možnosťou obličkového postihnutia. Rheuma-Liga uvádza, že zápal v tomto kontexte možno zachytiť vyšetrením moču a medzi prvé viditeľné varovania patria napríklad opuchy členkov pre zadržiavanie tekutín. Ak sa moč „pení“, môže to byť signál vysokého obsahu bielkovín a pacient by mal byť vyšetrený lekárom.

Pre prax: pri kolagenóze netreba podceňovať nález v moči, zmeny hydratácie ani edémy, pretože práve nefritída môže rozhodnúť o prognóze.

B) Svaly: keď dominuje slabosť, mysli na myozitídové spektrum

Ak dominuje svalová slabosť, príčinou môže byť podľa Rheuma-Ligy polymyozitída alebo dermatomyozitída. V laboratóriu sa typicky hľadajú zvýšené svalové enzýmy. K diagnostike pomáha ultrazvuk svalov, včasné informácie môže priniesť MRI a podľa potreby sa používa elektromyografia. Definitívny dôkaz zápalových procesov vo svale môže poskytnúť biopsia.

Pre prax: pri svalovej slabosti nestačí subjektívny dojem a jeden odber. Treba skombinovať kliniku, enzýmy a zobrazovanie a zistiť, či ide o zápalové postihnutie, ktoré môže odpovedať na imunosupresiu.

3) Autoprotilátky: silný smerovník, nie náhrada kliniky

Autoprotilátky môžu diagnózu výrazne urýchliť. Rheuma-Liga uvádza, že antinukleárne protilátky (ANA) sú pri kolagenózach typicky prítomné a bližšie určenie typu protilátok pomáha rozlíšiť jednotlivé kolagenózy.

Príklady:

- pri aktívnom systémovom lupus erythematosus sa môžu v krvi zisťovať protilátky proti dsDNA (anti-dsDNA),
- pri Sjögrenovom syndróme sa nájdu iné podskupiny ANA, napríklad anti-Ro a anti-La.

Pre prax: ak protilátky „nesedia“ k fenotypu, výsledok neznamená hotovú diagnózu ani jej vylúčenie. Je to signál, ktorý treba dať do súvisu s orgánovým postihnutím a vývojom v čase.

4) Terapeutická logika: liečiť podľa rizika orgánov, nie podľa subjektívneho dojmu

Terapeutické výzvy, o ktorých hovorí podujatie Kollagenosen 2026, v klinickej praxi znamenajú, že liečbu nemožno správne nastaviť bez jasnej odpovede na tri otázky:

- čo je aktívne (zápalová aktivita),
- kde je aktívne (ktorý orgán je ohrozený),
- a aké je riziko rýchlej progresie.

Od toho, či pacient „má príznaky“, alebo má aktívne orgánové ohrozenie, závisí, ako rýchlo a ako intenzívne treba rozhodovať.

5) Praktický algoritmus uvažovania v piatich krokoch (nejde o jediný možný postup)

1. **Zmapuj fenotyp:** symptómy a fyzikálne nálezy.
2. **Zhodnoť orgány:** moč, funkcie, svalová slabosť, dýchacie prejavy, neurologické znaky – podľa domény.
3. **Doplň laboratóriá a zobrazovanie:** cielene (nie všeobecne „čo vyjde“).
4. **Interpretuj protilátky v kontexte:** ANA a špecifické protilátky sú smerovník, nie rozsudok.
5. **Ak otáznik mení manažment, zintenzívni diagnostiku:** vrátane zvažovania mikroskopického vyšetrenia, ak je to naozaj rozhodujúce.

6) Záver

Kolagenózy sú diagnosticky náročné, pretože sa prejavujú rôznorodo a pomer medzi systémovými symptómami a orgánovým rizikom sa často mení. Najviac pomáha orgánový prístup: klinika spojená s hodnotením funkcie orgánov, cielené laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia a interpretácia autoprotilátok v kontexte pacienta.

Manažment má byť nastavený tak, aby chránil orgány včas.

Zdroj (podujatie): *streamed-up.com, „Kollagenosen 2026“ (RheumaLive, 2026). Link na zdroj.*

Zdroj (diagnostika kolagenóz): *Rheuma-Liga, „Kollagenosen“. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kolagenozy-klinicky-pohlad-nefrologa-diagnostika-organy · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.